

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-06	01	10 DIC 2020	10 DIC 2022

1.-OBJETIVO

Evaluar el riesgo de caída para reducir la probabilidad de ocurrencia de éstas e identificar áreas, momentos o procedimientos, que involucren a pacientes con necesidad de evaluación y reevaluación, y determinar al responsable de evaluarlo y llevar a cabo las medidas de reducción del riesgo a dichos pacientes.

2.-ALCANCE

Es competencia de todo el equipo multidisciplinario, salvaguardar la integridad y disminuir el riesgo de toda persona que ingrese en calidad de paciente, ya sea ambulatorio, de urgencias u hospitalizado y en todo momento que este permanezca en las instalaciones, hasta su egreso.

3. RESPONSABILIDADES.

3.1 Actualización: Jefatura de enfermería.

3.2 Ejecución: Equipo multidisciplinario.

3.3 Supervisión: Dirección Médica

4.- DESARROLLO DEL PROCESO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Equipo multidisciplinario	Al ingreso del paciente a cualquier área de atención médica se realizará la valoración del riesgo de caída del paciente de manera rápida observando: • Dificultades para caminar • Incapacidad mental o cognitiva • Pacientes con necesidad de auxiliares para acompañar la marcha
		Este proceso será de manera estandarizada y en el primer contacto que esté tenga con cualquier personal del área de atención médica.
2		Se valora la condición del paciente, alteración mental, edad, estado anímico y limitaciones físicas o neurológicas. (Que tablas o métodos se utilizan para la valoración)
3		Se han determinado áreas críticas como urgencias, quirófanos, hemodiálisis, UTI, pediatría, a su vez, pacientes con situaciones especiales o características clínicas específicas, como pacientes pediátricos, pacientes

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-06	01	10 DIC 2020	10 DIC 2022

		psiquiátricos, o pacientes con alteración del estado neurológico. Situaciones que generan incremento del riesgo: • Dificultad para el movimiento o inestabilidad. • Alteraciones visuales. • Intervención quirúrgica recientemente. • Medicamento que altere la percepción o produzca sueño. • Presenta baja presión o hipoglucemia. • Si tiene enfermedades neurológicas (convulsiones). • Enfermedades cardíacas con arritmias o un marcapasos con inestabilidad reciente. • uso sonda o algún equipo instalado sobre su cuerpo.
4	Enfermería	Al ingreso a habitación o área crítica la valoración del riesgo de caída será por medio de la escala de MORSE, la cual se encuentra dentro de los formatos de hoja de enfermería.
5		En el ingreso de paciente por área de urgencias, se realizara la misma escala valoración y se realizarán las prevenciones de riesgo de caída.
6		El valor obtenido en la escala, se registrará en el <i>FT-JE-01 hoja de enfermería</i> , y se evidenciará en la ficha de identificación con color "AZUL" para un riesgo bajo, "NARANJA" riesgo medio y "ROJO" riesgo alto, colocando a su vez la puntuación obtenida. (<i>criterios</i>)
7		Realizara la valoración del riesgo de caída cada 24 horas o antes, si se presenta algún cambio en el estado clínico del paciente.
8		Registrará la puntuación obtenida en los registros de enfermería, a su vez registrara las acciones realizadas para prevenir el riesgo.
9		Se debe reevaluar el paciente en los siguientes momentos: Cambio de turno. Cambio de área o servicio. Cambio en el estado de salud. Cambio o modificación del tratamiento. Cambio en el estado neurológico.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-06	01	10 DIC 2020	10 DIC 2022

10	Enfermería	ACCIONES A REALIZAR Asegurar un entorno seguro, iluminación, ubicación de objetos (mobiliario, Tripie, cables).
11		Se elevaran los barandales de la cama, educando al paciente y familiar sobre su uso.
12		Verificar la activación del freno de la cama y explica funcionamiento a paciente y familiar.
13		Se educara el uso del timbre y teléfono, los cuales deben estar siempre al alcance del paciente.
14		Fomentar la realización de prácticas seguras como uso de calzado adecuado, no deambular con pisos mojados, utilizar equipo de apoyo para la deambulacion (andadera, muletas).
15		Se educara al paciente y/o familiar las medidas de seguridad requeridas para el autocuidado y la prevención de caída: Uso de barandales. Apoyo de accesorios para la deambulacion (andaderas, muletas, banco de altura) Estado anímico. Estado neurológico.
16	Enfermería	En caso de requerir apoyo para realizar alguna actividad, se solicitara el apoyo del servicio de camillería.
17		Pacientes pediátricos: - Niños menores de 3 años serán colocados en cunas. - Se educara a los padres las medidas de seguridad aplicables al paciente pediátrico. - Siempre estarán acompañados por padres o representante legal. - Se mantendrá barandales elevados ya sea cuna o cama.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-06	01	10 DIC 2020	10 DIC 2022

		- Se mantendrá siempre en uso el freno de la cama o cuna. - En caso de que el familiar requiera salir, se hará reemplazo con otro familiar, nunca dejando solo al menor en la habitación, si es necesario pedirá apoyo a enfermería. - Siempre se mantendrá apoyo para la incorporación del menor. - Se favorecerá la eliminación. - Toda actividad que se realice al menor será con autorización de los padres o tutores.
18		Pacientes psiquiátricos: - Se valora el estado de conciencia del paciente. - Se educara al familiar acompañante las medidas de seguridad aplicables al paciente. - Siempre estará acompañado por familiar. - Se mantendrá barandales de la cama elevados. - Se mantendrá siempre en uso el freno de la cama. - En caso de que el familiar requiera salir, se hará reemplazo con otro familiar, nunca dejar solo al paciente en la habitación, si es necesario pedirá apoyo a enfermería. - Crear un ambiente seguro y de tranquilidad para no alterar e inquietar el estado mental del paciente. - En caso de ser necesario se realizara sujeción gentil, siempre con previo consentimiento informado y firmado por familiar o representante legal. - Favorecer el uso de cómodos o pañales para la eliminación, siempre y cuando no se recomiende la deambulación. - Se pedirá apoyo de camillería siempre que se requiera realizar alguna actividad que implique la movilización del paciente o traslado.
19	camillería	Atenderá oportunamente la solicitud de apoyo para realizar alguna actividad que requiera movilizar al paciente.
20		Colabora con las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de caída. (uso de barandales, freno de cama)
21		Valora el traslado de paciente siempre que se requiera mover de una área a otra, y determina el uso del dispositivo para traslado (silla de ruedas, camilla).

Código:
PR-JE-06

Versión vigente:
01

Fecha de emisión:
10 DIC 2020

Fecha de revisión:
10 DIC 2022

22		Informará a su superior cualquier falla o desperfecto en el equipo de traslado de paciente.
23		

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 Ponderación de riesgos

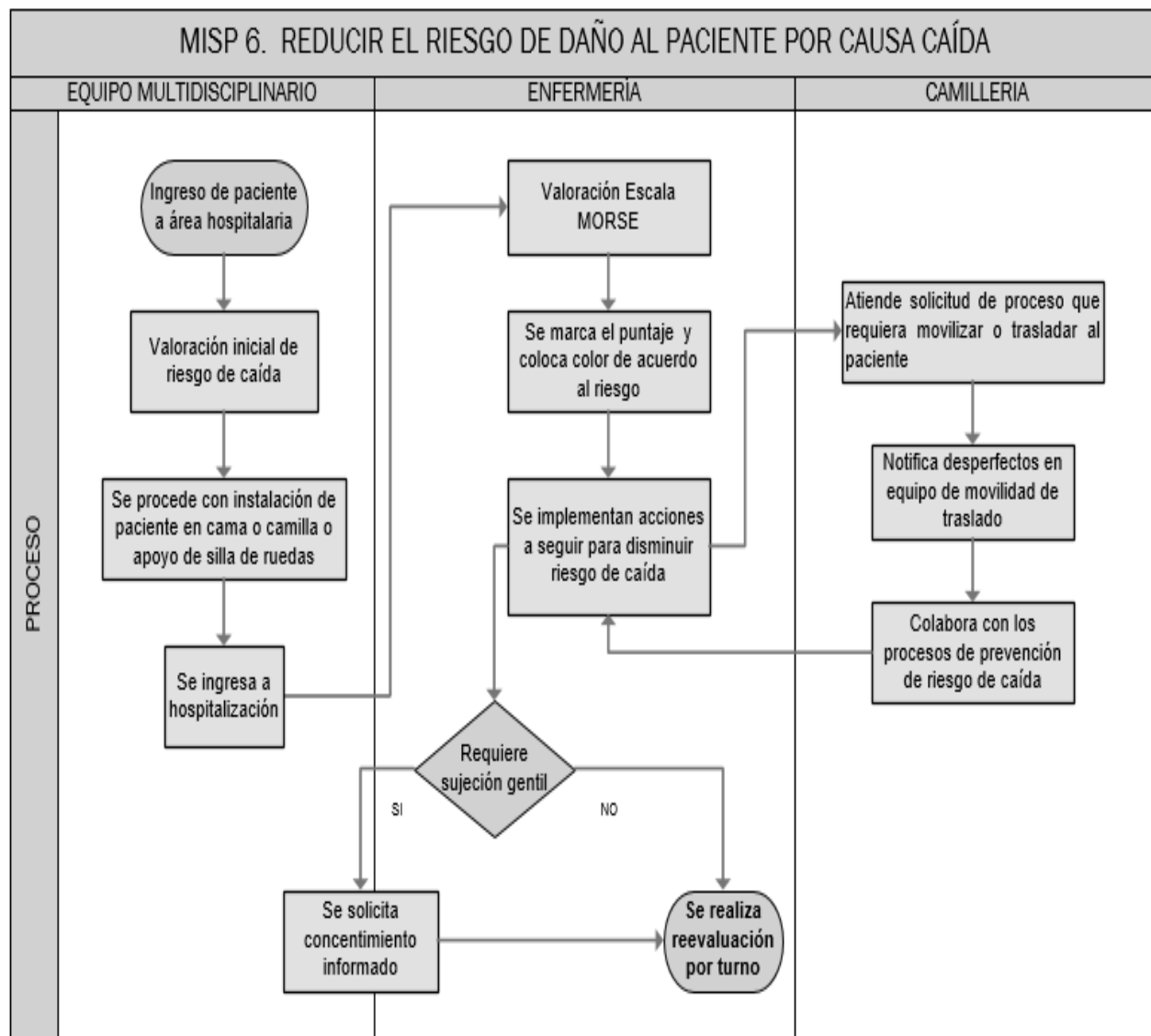
- a) Desconocimiento de la escala de valoración de riesgo de caída MORSE.
- b) Clasificación errónea del riesgo de caída.
- c) Disfunción de los accesorios de seguridad (barandales de cama, andaderas, timbre).
- d) No realizar comunicación efectiva entre equipo multidisciplinario, pacientes y familiar.
- e) No aplicar las medidas de seguridad necesarias según su valoración.

5.2 Barreras de seguridad

- a) Educar al equipo multidisciplinario sobre el uso de la escala de valoración MORSE.
- b) Estandarizar los criterios de valoración por medio de la escala MORSE y la valoración del paciente.
- c) Revisión continua de equipo y notificación oportuna de disfuncionalidad.
- d) Promover el apego de prácticas seguras que disminuyan el riesgo de caída en los pacientes.

6.- ANEXOS

6.1 Diagrama de flujo



6.2 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Hoja de valoración inicial de enfermería	FT-JE-24
Hoja de enfermería	FT-JE-01
Escala de MORSE	

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-06	01	10 DIC 2020	10 DIC 2022

7. CONTROL DE CAMBIOS.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
1	10/12/20	Alta de documento	Lic. Enf. Gerardo Toledo Casas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2				
3				

8. AUTORIZACIONES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Enf. Gerardo Toledo Casas.	Lic. Enf. Felicitas Mariela Vargas Román	Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
JEFATURA DE ENSEÑANZA	DIRECCIÓN MEDICA	DIRECCIÓN MEDICA